

病院広報を 「関係構築・関係支援」へ

対話型プロトタイプを起点とした成立可能性の相談

CORE Communication Console

完成製品の導入提案ではなく、
臨床・病院運用上の助言をいただくための相談です。

固定シナリオ

実患者データなし

成立可能性の相談

なぜ、病院広報を再定義するのか

医療では、患者・家族が理解し、考え、
医療者とともに意思形成へ参加することが、より重視されるようになった。

医療情報を、
自分の状況に置き換えにくい

医学的根拠と生活が、
そのままではつながらない

必要な支援が、
複数の部門・職種にまたがる

情報を伝える広報から

患者・家族と病院の関係を構築し、支える広報へ。

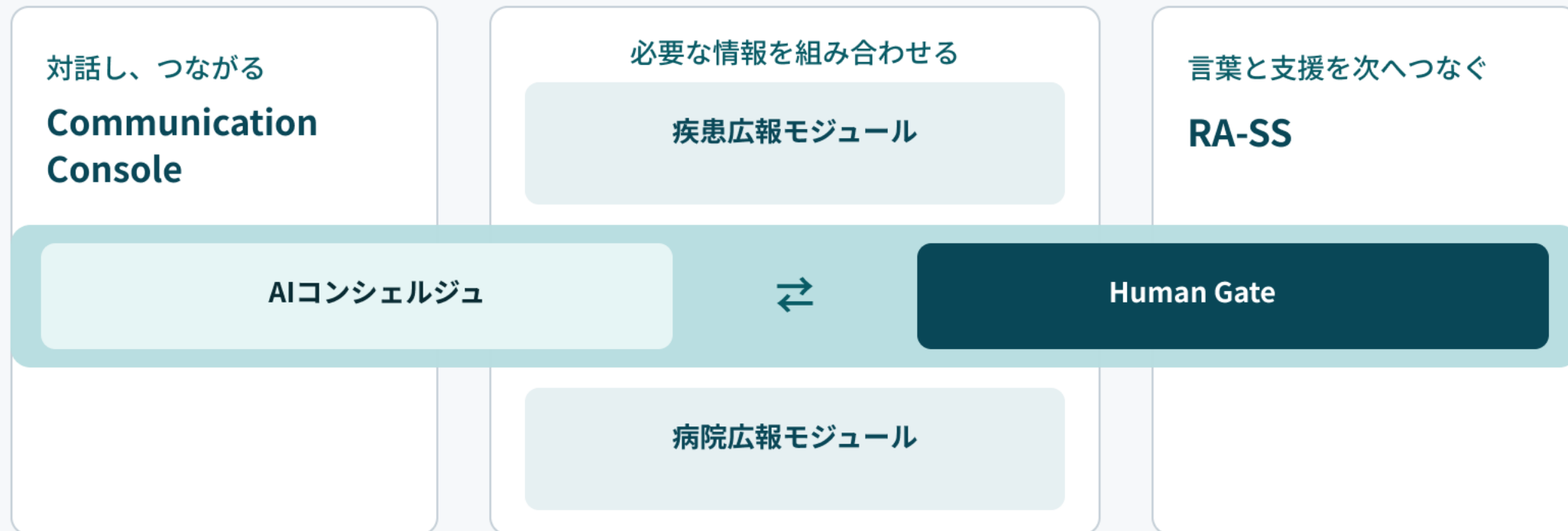
従来の情報発信を否定するのではなく、情報が理解・対話・人的支援へつながるところまで役割を広げる。

実装構造へ →

関係支援は、どう動くのか

02 関係支援の実装構造

関係支援は、対話・情報・引き継ぎという三つの仕組みが連動して動く。



AIが候補をつくり、人が確認・修正・判断する。
人の確認結果を、次の対話・情報・支援へ戻す。

[プロトタイプを見る →](#)

プロトタイプでは、何を見るのか

03 プロトタイプへの接続

一つの言葉が、必要な情報と人につながり、
支援後にも残る課題が次へ渡される。



ここからは、原則として説明を挟まず
一続きの体験としてご覧ください。

デモで、何が動作する形になったのか

04 デモの意味を整理する

デモで見た一連の体験を、関係支援の構造として実装した。

患者・家族の言葉から始める



Communication Console

必要な情報を組み合わせる



疾患広報+病院広報モジュール

AIによる整理と、人による確認を分ける



AIコンシェルジュ ⇄ Human Gate

支援後の変化と残る課題を保持する



RA-SS

動作する形で可視化できた。

臨床的有効性と院内運用上の成立は、これからPoCで確認する。

なぜ今、この構造を動かせるのか

05 なぜ今、実装可能になったのか

医療情報の体系と、散逸する情報を柔軟に組み合わせる実装環境を、接続して扱えるようになってきた。

医療情報を整理する座標

ICD	疾患を分類する
DPC	診断群分類・入院医療を整理する
診療ガイドライン	医学的根拠を示す
クリティカルパス	診療・支援を時間軸で示す

散逸情報を構成し、動かす環境

AI+外部記憶	GPT+Notion 整理し、合意を読み戻す
実装+履歴	Codex+GitHub 考えを検証可能な実装へ
動作体験	React 一連の体験として可視化
将来接続	API 段階的な検証事項

体系性を保ちながら、患者・家族のContextに応じて
必要な情報を柔軟に構成できるようになった。

電子カルテを置き換えず、診療記録の手前と周辺にコミュニケーション層を置く。

一疾患・全場面PoCへ →

次に、何を確認めるのか

06 一疾患・全場面PoCへ

設計対象は一疾患・全場面。実装と実地検証は、代表場面から段階的に進める。

現在地

一疾患・一場面

大腿骨頸部骨折
手術後・退院準備

固定プロトタイプ



次の設計対象

一疾患・全場面

全経過を、一つの情報構造として設計する

受傷・救急



診断・入院



治療・手術



リハビリ

退院準備



自宅・転院



退院後



再確認・二次予防

全場面を一度に実装するのではない。

現場負担を確認しながら、代表場面から段階的に進める。

率直に、このプロトタイプは何に見えましたか？

正解を求める質問ではありません。違和感も含めて、率直なご意見を伺いたいと思います。

01

広報の再定義

関係構築・関係支援として
成立するでしょうか

02

PoCの単位

一疾患・全場面という設計対象は
妥当でしょうか

03

次の一步

どの場面・職種・人から
確かめるべきでしょうか

今回の成功条件

次に確かめる問いと、次に相談する人が明らかになること。

承認を得る場ではなく、次の検証条件を明らかにするための相談です。